EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 86521
SERVICIO : MEL MUJERES HSC
FECHA : 12-06-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: AUGUSTO OMAR GONZALEZ VERA			**RUN**	: 6.010.601-0
F.Nac	: 20-09-1947	**Edad**	: 76 AÑOS, 8 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: OSSA 746			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 50593625		
Fecha Ingreso	: 2024-06-07	**Fecha Egreso**	: 12-06-2024	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnósticos:
1. Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica resuelta
- NAC bibasal tratada PSI: V | SMART COP: riesgo moderado
2. AKI KDIGO II No Oligurica prerrenal resuelta
3. Tumor renal derecho
--> En estudio urologico para etapificacion
4. Epilepsia en tratamiento
5. Hipertensión arterial refractaria

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. D41.0-TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL RINON (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. G40.9-EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino de 76 años consulta en SU el día 07/06 por cuadro de 3 dias de evolucion previos al ingreso de dolor epigástrico intenso irradiado a dorso, con vómitos asociados. Además refiere tos irritativa y coriza de 3 días de evolución. Ingresa a SU hipertenso, afebril, sin compromiso ventilatorio aparente. Se realiza estudio laboratorio donde destaca patrón colestásico, amilasa y lipasa negativa, TC con TU renal derecho y quistes renal bilateral, sin hallazgos de compromiso de vía biliar. Fue evaluado por cirugía, descartando cuadro quirúrgico agudo o de origen biliar. Durante evaluación en SU presenta compromiso ventilatorio progresivo, con requerimiento de FiO2 suplementaria en ascenso, pese a broncodilatación y administración corticoides, con gasometría que evidencia hipoxemia. Se realiza AngioTC de tórax que descarta TEP, pero se observan pequeños focos de condensación en las bases. EKG sin signos de isquemia aguda. Antígeno viral negativo (Influenza, Covid, VRS) . Se decide ingreso a UTI para apoyo ventilatorio dado requerimientos de O2 con CNAF y continuar estudio. paciente evoluciona estable en UTI, sin episodios de delirum activo, se realiza estabilizacion ventilatoria, requirio monitorizacion invasiva con uso de DVA en UPC, se inicia antibioticoterapia empirica con ceftriaxona + azitromicina, y kinesioterapia para mejoria de mecanica ventilatoria. eventual disminucion progresiva del O2 suplementario, hasta NRC, se traslada a sala basica en esables condiciones generales, con tendencia a la hipertension, eucardico, eupneico, afebril, disminuye los requerimientos de O2

progresivos, hasta destete, clinicamente ingresa con sibilancias auscultables sin fonendoscopio, con kinesioterapia intensiva 3 veces al dia logrando destete de o2 hace 48 horas, desde el punto de vista paraclinico paciente con parametros inflamatorios a la baja PCR 192-->221--> 63--> 27, GB 38700-->30800--> 8600. UC negativo /HC negativos del 07.06. LRA KDIGO 2 recuperada a su basal crea 1.6 --> 1.0, ELP 145/3.5/110. Metabolicamente estable, funcion renal normalizada respecto a basal, con actualmente 4 dias de ceftrizaxona y 3 de azitromicina, mantiene buen control glicemico, buena tolerancia a la vía oral, diuresis espontanea, deambulacion presente bien tolerada, dado evolucion favorable, se decide alta a domicilio para completar tratamiento EV + KTR por 3 dias hasta completar 7.

PLAN DE MANEJO:

- Continuar tratamiento medico antibiotico EV hasta completar 7 dias de ceftriaxona EV en HODOM, continuar con azitromicina via oral hasta completar 7 dias
- KTR en visita domiciliaria
- Continuar con seguimiento por urologia en contexto de neoplasia renal ingresada a GES, informe de TAC AP C/C entregado a familiar
- Retomar controles cronicos en APS, ajusto tratamiento de base, extiendo receta por 30 dias

INDICACIONES AL ALTA

1. Continuar manejo en HODOM
2. Reposo relativo asistido
3. Régimen liviano bajo en sal
4. Hidratacion oral abundante
5. Ceftriaxona 2 gr/día ev 4/7 x 3 dias, completar en HODOM
6. Azitromicina 500mg c/dia vo x 4 dias (3/7)
7. Fenitoína 100 mg c/12 hrs vo
8. Bromuro ipratropio 2 puff c/6hrs por AEC
9. Salbutamol 2 puff c/6 horas por AEC
10. KTM y KTR en HODOM
11. Paracetamol 500mg 2 c/8 horas vo SOS
12. Omeprazol 20mg c/dia vo
13. Losartan 50mg c/12 mg vo
14. Amlodipino 10mg c/24 mg vo
15. Furosemida 40mg 1 c/dia vo
16. Hidralazina 50mg c/8 horas vo
17. Continuar controles en Urologia via GES, paciente ya ingresado
18. Ante signos de alarma ya explicados acudir nuevamente a SU

EXÁMENES Y RESULTADOS

Angio TAC de tórax que descarta TEP, pero se observan pequeños focos de condensación en las bases. EKG sin signos de isquemia aguda. Antígeno viral negativo (Influenza, Covid, VRS)
PCR 192-->221--> 63--> 27, GB 38700-->30800--> 8600. UC negativo /HC negativos del 07.06. Crea 1.6 --> 1.0, ELP 145/3.5/110.
TAC AP: tumor renal bilateral, con lesion tumoral derecha heterogenea en contexto de neoplasia renal

OBSERVACIONES:

-

Control en: 7 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO